第 七 章

生病了，去哪儿

> 「药不管用」不是原因，是算完账之后，说给自己听的理由。

发烧到 38 度，你从抽屉里翻出上个月剩的感冒药，吃了两片。

同桌说：别去，那儿的药不管用。

你问她去过吗。她说没有，都这么说。

你想了想，也是。

几乎每个班都发生过的对话

7.1 不去，是一笔算过的账

先把这件事说破：「药不管用」通常不是先去了解、再下的判断。它是决定已经做完之后，补上的一句解释。

真实的账是这样的。去一趟的成本是确定的：跟老师请假、下楼、排队、把哪儿难受说清楚、可能落掉一节课，有的学校还要通知家里。而收益是不确定的：你也不知道去了能不能好。

确定的成本，换一个不确定的收益。任何人算这笔账，答案都是不去。这跟勇敢不勇敢没关系，是账算得没错。

那「听说不管用」是怎么变成共识的？有个细节值得看：**说这话的人，多半没去过**。

而这条消息在传的时候，天生是偏的。去了、好了的人，不会特意回来说一句「其实有用」；去了、没立刻好的人，一定会说。你听到的样本，从源头就是斜的。

当然有一半是真的：医务室能给的多是对症的常用药，重的它处理不了，只能往外转。这点没冤枉它。但「吃了第二天没好」不等于药没用——感冒本来就要一周。药管的是难受，不管好得快。

所以真正的问题不在「该不该去」，在这笔账里有一项被漏掉了：**拖**。多数小毛病会自己好，但有一些不会。而拖过某个点，代价会从「一节课」跳到「一周」。

还有一项被低估了：医务室真正值钱的地方不是给药，是判断你到底要不要出去。这件事它比你有经验。

于是问题可以换个问法：不是「值不值得去」，是「这一次，是不是那种会自己好的」。

7.2 值得跑一趟的情况

外伤：扭伤、划伤、烫伤。

发烧：38.5 以上，或者低烧持续两天。

急性腹泻、呕吐。

过敏：起疹子、痒、局部肿。

任何疼到影响上课的疼痛。

这几类有共同点：要么当场就能处理，要么处理不了也得赶紧往外转。都属于「去了不亏」——而且都是「不会自己好」的那种。

7.3 去了怎么说

三句话，按这个顺序说：

1. **什么时候开始的**
   「前天晚上」「今天早自习」。

2. **什么感觉**
   「是胀，不是疼」「一阵一阵的」「按下去更疼」。形容得越具体，越省时间。

3. **有没有变重**
   「昨天还好，今天开始吐」。这一句决定了对方紧不紧张。

如果你记过——什么时候开始的、吃了什么、疼了多久——直接拿出来。它比「我难受」有用得多。

7.4 抽屉里该有什么

既然多数时候是自己扛，那手上有什么就很重要。一份最基本的清单：

通用名	用来对付	注意
对乙酰氨基酚	发烧、头痛	很多复方感冒药里已经有它，别叠加着吃
布洛芬	痛经、头痛、牙痛	别空腹吃；胃不好的饭后吃
蒙脱石散	急性腹泻	和其他药隔开两小时，它会吸附别人
口服补液盐	腹泻、呕吐后补水	别用运动饮料代替，糖和盐的比例不对
氯雷他定	过敏起的疹子、痒	不太犯困，但别和含抗过敏成分的感冒药叠着吃
碘伏棉签、创可贴	小伤口	伤口脏要先冲洗，再消毒
体温计	判断要不要报	电子的就够，别凭手感猜

剂量这里一个都不给。同一个药名，片剂和缓释胶囊的用法就不一样，年龄体重也影响用量——这种事只能看说明书或者问医生。这里能做的是告诉你「它大概是干什么的」，以及「什么时候别乱搭」。

另外：每年开学清一次抽屉，过期的扔掉。药过期不是「效果差点」，是有的会分解出不该有的东西。

7.5 红旗症状

比第一章那张更全，也更重。第一章那张管「该去医务室」，这张管「该往外转」。出现任何一条，不用再观察。

这九条，一条都不用过夜

- 大便发黑、像柏油，或者呕出血
- 肚子持续剧痛超过 6 小时，而且越来越重
- 发烧超过 39℃，或者发烧三天不退
- 明显脱水：口干、尿少、站起来发晕
- 呼吸困难、胸闷、心跳一直很快
- 意识模糊，叫不太应
- 剧烈头痛，伴呕吐或者脖子发硬
- 过敏时嘴唇、喉咙肿起来，喘不上气
- 伤口红肿热痛在扩散，或者有脓

这几条不代表一定很严重。但它们都过了「自己扛一扛」的界限，需要有人看一眼。

7.6 什么时候该请假

硬扛一节课，是意志问题。硬扛一天，是判断问题。

该请的情况：发烧、呕吐腹泻、疼到没法集中注意力、有传染性的（流感、诺如）。

最后一条值得多说一句：带病上课不是勤奋。它把一个班拖下水，也让你自己好得更慢——这一天的课没听进去，后面三天还得补。

能忍不算本事。忍到撑不住那天，落下的课更多。